



Yth.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Prima Husada Sukorejo
Komite Medik RS Prima Husada Sukorejo
Seluruh DPJP RS Prima Husada Sukorejo

SURAT EDARAN

NOMOR : 835/RSPHS/I-SE/DIR/VII/2024

TENTANG

TATALAKSANA DAN DIAGNOSIS PNEUMONIA

Menindaklanjuti sosialisasi BPJS Kesehatan mengenai Utilization Review RS Prima Husada Sukorejo dan upaya pengendalian mutu dan kendali biaya, Serta sehubungan dengan permasalahan pending / dispute klaim terkait diagnosis dan tatalaksana pneumonia, maka disampaikan beberapa kebijakan sebagaimana berikut :

1. Diagnosis dan Tatalaksanan Pneumonia dewasa perlu memperhatikan beberapa hal berikut :
 - a. Diagnosis pneumonia harus dilakukan foto thoraks di sertai minimal 1 tanda klinis sesuai kriteria yang tercantum PNPKE PNEUMONIA PADA DEWASA halaman 11-12 yaitu dengan gejala dan tanda di bawah ini :
 - 1) Batuk
 - 2) Nyeri dada
 - 3) Sesak napas
 - 4) Perubahan karakteristik sputum / purulent
 - 5) Suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (aksila) / riwayat demam
 - 6) Pada pemeriksaan fisis dapat ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki
 - 7) Jumlah leukosit $\geq 10.000 \text{ sel/}\mu\text{L}$ atau $< 4500 \text{ sel/}\mu\text{L}$ dengan peningkatan neutrofil batang atau *immature granulocytes*

Adapun manifestasi klinis pneumonia komunitas pada pasien lanjut usia umumnya tidak khas. Gejala awal pada lansia dapat berupa penurunan kesadaran atau disorientasi aitan baru maupun perburukan dengan beberapa gejala lainnya seperti penurunan nafsu makan.

- b. Pasien Pneumonia dirawat inap sesuai indikasi dan score dan derajat pneumonia ditulis dalam Resume sesuai PSI/CURB 65 atau IDSA/ATS 2007
 - c. Pasien Pneumonia yang dirawat pemberian dan evaluasi antibiotik paling cepat dilakukan dalam 72 jam sesuai PNPKE PNEUMONIA PADA DEWASA
 - d. Semua pasien pneumonia yang dirawat inap diperiksa pemeriksaan mikrobiologi (kultur sputum) sesuai dengan kemampuan rumah sakit apabila hasil thoraks kurang memperkuat diagnosa pneumonia.
2. Berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Pneumonia Pada Dewasa dijelaskan bahwa,



- a. LOS Diagnosa Pneumonia lebih dari 3 hari dan dan terdapat penatalaksanaan pemeriksaan kultur
- b. Strategi terapi awal untuk pasien pneumonia komunitas rawat inap sebagaimana terlampir :

Pasien pneumonia tidak berat rawat inap (<i>Nonsevere inpatient pneumonia</i>)	
Regimen standar	• β-laktam ditambah makrolid ATAU • Fluorokuinolon respirasi
Riwayat isolasi MRSA pada sampel respirasi sebelumnya	• Tambahkan antibiotik yang mencakup MRSA, dan • Dapatkan kultur atau PCR nasal untuk deeskalasi atau konfirmasi kebutuhan untuk melanjutkan terapi
Riwayat isolasi <i>Pseudomonas aeruginosa</i> pada sampel respirasi sebelumnya	• Tambahkan antibiotik yang mencakup P. aeruginosa, dan • Pemeriksaan biakan sputum atau bilasan bronkus atau PCR nasal untuk deeskalasi atau konfirmasi kebutuhan untuk melanjutkan terapi
Riwayat perawatan di rumah sakit dan mendapatkan antibiotik parenteral (<90 hari terakhir) dan memiliki faktor risiko untuk MRSA yang tervalidasi secara lokal	Lakukan pemeriksaan, namun jangan menambahkan antibiotik yang mencakup MRSA kecuali hasil kultur terbukti positif MRSA Jika rapid nasal PCR tersedia, jangan menambahkan antibiotik untuk MRSA jika hasil negatif. Jika hasilnya positif, tambahkan antibiotik untuk MRSA dan lakukan pemeriksaan kultur
Riwayat perawatan di rumah sakit dan mendapatkan antibiotik parenteral (<90 hari terakhir) dan memiliki faktor risiko untuk P. Aeruginosa yang tervalidasi secara lokal	Lakukan pemeriksaan kultur, namun hanya berikan antibiotik untuk P. <i>Aeruginosa</i> jika hasil kultur positif

3. Indikasi Pasien Pneumonia Rawat Inap / Jalan SKOR CURB dijelaskan sebagaimana berikut :

a. CURB -65

Sistem skor ini dapat mengidentifikasi apakah pasien dapat berobat jalan atau rawat inap, dirawat di ruangan biasa atau intensif. Pneumonia Severity Index (PSI) menggunakan 20 variabel, ada riwayat penyakit dasarnya serta umur mendapat nilai yang tinggi. CURB-65 lebih mudah cara menghitungnya karena yang dinilai hanya 5 variabel tetapi tidak dapat langsung mengetahui penyakit dasarnya.

Skor CURB-65 adalah penilaian terhadap setiap faktor risiko yang diukur. Sistem skor pada CURB-65 lebih ideal digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan tingkat angka kematian tinggi. Setiap nilai faktor risiko dinilai satu. Faktor-faktor risiko tersebut adalah:



C : Confusion yaitu tingkat kesadaran ditentukan berdasarkan uji mental atau adanya disorientasi tempat, waktu, atau orang yang baru.

U : Ureum.

R : Respiratory rate atau frekuensi napas.

B : Blood pressure atau tekanan darah.

65 : Umur $\geq$ 65 tahun.

Tingkat kesadaran dinilai berdasarkan Abbreviation Mental Test (Uji Mental) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Tingkat kesadaran berdasarkan uji mental

Respons	Nilai
Umur	
Tanggal lahir	
Waktu (untuk jam terdekat)	
Tahun sekarang	
Nama rumah sakit	
Dapat mengidentifikasi dua orang (misalnya dokter, perawat)	
Alamat rumah	
Tanggal kemerdekaan	
Nama raja/ presiden	
Hitung mundur (mulai dari 20 kebelakang)	

Catatan:

- 1) Ada 10 pertanyaan.
- 2) Tiap pertanyaan dijawab dengan benar mendapat nilai satu.
- 3) Jawaban yang benar nilai $\leq 8 \rightarrow$ confusion $\rightarrow$ skor 1.
- 4) Jawaban yang benar nilai $> 8 \rightarrow$ skor 0.

Setelah didapatkan skor untuk confusion maka kemudian dinilai skor lainnya yaitu ureum, frekuensi napas, tekanan darah dan umur. Total skor yang didapat digunakan untuk menentukan apakah pasien dapat berobat jalan atau rawat inap, dirawat di ruangan biasa atau ruangan perawatan intensif.

Tabel Skor CURB-65

Confusion Uji mental $\leq$ nilai 8 $\rightarrow$ skor 1 Uji mental $>$ nilai 8 $\rightarrow$ skor 0
Ureum Ureum > 40 mg/dL skor 1 Ureum < 40 mg/dL skor 0
Respiratory Rate (RR) RR > 30 x/menit skor 1 RR < 30 x/menit skor 0



Blood pressure (BP) BP < 90/60 mmHg skor 1 BP > 90/60 mmHg skor 0
Umur Umur > 65 tahun skor 1 Umur < 65 tahun skor 0

Penilaian berat pneumonia dengan menggunakan sistem skor CURB-65 adalah sebagai berikut:

1. Skor 0 – 1 : risiko kematian rendah, pasien dapat berobat jalan dengan hasil 0 atau salah satu dari kriteria CURB 65 (Confusion, Ureum > 40 mg/dL, Frekuensi nafas ≥ 30 x/menit, Tekanan Darah : Sistolik < 90 mmHg dan diastolic ≤ 60 mmHg)
2. Skor 2 : risiko kematian sedang, dapat dipertimbangkan untuk dirawat inap dengan skor 2 dari kriteria CURB 65 (Confusion, Ureum > 40 mg/dL, Frekuensi nafas ≥ 30 x/menit, Tekanan Darah : Sistolik < 90 mmHg dan diastolic ≤ 60 mmHg) dan memiliki Faktor modifikasi/komorbiditas: penyakit jantung, hati, atau ginjal yang kronis, diabetes mellitus, alkoholik, keganasan, asplenia, imunokompromais menggunakan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, adanya risiko streptococcus pneumonia resisten obat.
3. Skor ≥ 3 : risiko kematian tinggi dan dirawat harus ditata laksana sebagai pneumonia berat dengan skor ≥ 3 dari kriteria CURB 65 (Confusion, Ureum > 40 mg/dL, Frekuensi nafas ≥ 30 x/menit, Tekanan Darah : Sistolik < 90 mmHg dan diastolic ≤ 60 mmHg)
4. Skor 4 atau 5 : harus dipertimbangkan perawatan intensif, dengan skor 4-5 dari kriteria CURB 65 (Confusion, Ureum > 40 mg/dL, Frekuensi nafas ≥ 30 x/menit, Tekanan Darah : Sistolik < 90 mmHg dan diastolic ≤ 60 mmHg)

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijalankan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 10 Juli 2024
Direktur RS Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS